



ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชสารเสพติดก่อความรุนแรง (SMI-V) ในเขตสุขภาพเข้า
ถึงบริการได้รับการดูแลต่อเนื่องและไม่ก่อความรุนแรงซ้ำ

ตัวชี้วัด MONITOR

นายวรสันต์ แผ่นพรหม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์
กรมสุขภาพจิต



ระดับตัวชี้วัด

**ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชสารเสพติดก่อความรุนแรง (SMI-V)
ในเขตสุขภาพ เข้าถึงบริการต่อเนื่องและไม่ก่อความรุนแรงซ้ำ**
ตัวชี้วัดย่อย ร้อยละการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคจิตเวชยาเสพติดที่มีความเสี่ยงสูง
ต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V)

**ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชสารเสพติดก่อความรุนแรง (SMI-V)
ในเขตสุขภาพ เข้าถึงบริการต่อเนื่องและไม่ก่อความรุนแรงซ้ำ**

ตัวชี้วัดระดับกระทรวง

ตัวชี้วัดการตรวจราชการในเขตสุขภาพ

ตัวชี้วัดระดับกรม

SMI-V Value Chain

แนวทาง/มาตรการป้องกัน แก้ไขปัญหาการก่อความรุนแรงในสังคม



- **V-care คัดกรอง**

ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ด้วย 5 สัญญาณเตือน

- **PEMS เฉพาะทางจิตเวช** ทุกเขตสุขภาพ
- **ดูแลผู้ป่วยใช้ยาเสพติดในชุมชน (CBRx)**
- **Cardiff Model แนวทางการป้องกัน**
ความรุนแรงในสังคม

- **บริการ Intermediate Care**

(มีนิรภัยรักษา)

- **บริการ Acute Care**
(หอผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด)
- **ER Fast track SMI-V** ใน sw.ทุกระดับ

- **LAI ในผู้ป่วย SMI-V**

- **บริการผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดที่บ้าน**
(Psychiatric Home Ward)
- **ระบบ V-care ดูแลต่อเนื่อง**
- **บริการ Long-term Care ดูแลต่อเนื่อง**
ในชุมชน (SMI-V Case Management)

ระบบสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง

IG ตรวจสอบการ

HDC

ระบบสารสนเทศ :

V-CARE (คัดกรอง)

HIS หน่วยงาน

V-CARE (ดูแลต่อเนื่อง)

กฎหมาย :

พ.ร.บ.สุขภาพจิต พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562

เป้าหมายและตัวชี้วัด Monitor

ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชสารเสพติดก่อนความรุนแรง (SMI-V) ในเขตสุขภาพเข้าถึงบริการได้รับการดูแลต่อเนื่องและไม่ก่อนความรุนแรงซ้ำ



เกณฑ์การประเมินผลเชิงปริมาณ (ค่าเป้าหมาย)



6 เดือน

9 เดือน

12 เดือน

- * ร้อยละ 35 การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคจิตเวชสารเสพติดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อนความรุนแรง
- * ร้อยละ 20 ของผู้ป่วยจิตเวชสารเสพติดก่อนความรุนแรง(SMI-V) ในเขตสุขภาพเข้าถึงบริการได้รับการดูแลต่อเนื่องและไม่ก่อนความรุนแรงซ้ำ

- * ร้อยละ 37 การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคจิตเวชสารเสพติดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อนความรุนแรง

- * ร้อยละ 40 การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคจิตเวชสารเสพติดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อนความรุนแรง
- * ร้อยละ 40 ของผู้ป่วยจิตเวชสารเสพติดก่อนความรุนแรง(SMI-V) ในเขตสุขภาพเข้าถึงบริการได้รับการดูแลต่อเนื่องและไม่ก่อนความรุนแรงซ้ำ



เกณฑ์การประเมินผลเชิงคุณภาพ (6 Building Blocks)



เกณฑ์การประเมินผลเชิงคุณภาพ	ระดับ 1 (0-40 คะแนน)	ระดับ 2 (41-55 คะแนน)	ระดับ 3 (56-70 คะแนน)	ระดับ 4 (71-85 คะแนน)	ระดับ 5 (86-100 คะแนน)
ด้านผลลัพธ์ • เฝ้าระวังคัดกรองด้วย V-SCAN ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป (5สัญญาณเตือน) เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการ	ชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน SMI-V ให้หน่วยงานในเขตสุขภาพ	> ร้อยละ 10 ประชาชนได้รับการเฝ้าระวัง/คัดกรองด้วย V-SCAN ในเขตสุขภาพ	> ร้อยละ 20	> ร้อยละ 30	> ร้อยละ 40
ด้านผลกระทบ • การเข้าถึงบริการ	ออกแบบ TEMPLATE กลาง เพื่อให้ข้อมูลแสดงหน้า DASHBOARD กระตรวจ สารสนเทศ	ข้อมูลแสดงหน้า DASHBOARD กระตรวจ	> ร้อยละ 30	> ร้อยละ 35	> ร้อยละ 40



ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชสารเสพติดก่อความรุนแรง (SMI-V) ในเขตสุขภาพ เข้าถึงบริการได้รับการดูแลต่อเนื่องและไม่ก่อความรุนแรงซ้ำ



เกณฑ์การประเมินผลเชิงปริมาณ
: ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย

ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย	
รอบ 6 เดือน	รอบ 10 เดือน
> ร้อยละ 20	> ร้อยละ 40

เกณฑ์การให้คะแนนเชิงปริมาณ
ในแต่ละระดับ

คะแนน	เกณฑ์ผลการดำเนินงาน	
	รอบ 6 เดือน	รอบ 10 เดือน
10	20	40
9	18	38
8	16	36
7	14	34
6	12	32
5	10	30
4	8	28
3	6	26
2	4	24
1	2	22

ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชสารเสพติดก่อความรุนแรง (SMI-V) ในเขตสุขภาพ เข้าถึงบริการได้รับการดูแลต่อเนื่องและไม่ก่อความรุนแรงซ้ำ



เกณฑ์การประเมินผลเชิงคุณภาพ ด้านผลลัพธ์ (Outcome) ตามกรอบแนวคิด 6 Building Blocks

การให้บริการสุขภาพ

Building Block	หัวข้อการประเมิน (นำมาจาก มาตรการหลัก)	เกณฑ์คุณภาพ ระดับ 1 0 – 40 คะแนน	เกณฑ์คุณภาพ ระดับ 2 41 – 55 คะแนน	เกณฑ์คุณภาพ ระดับ 3 56 – 70 คะแนน	เกณฑ์คุณภาพ ระดับ 4 71- 85 คะแนน	เกณฑ์คุณภาพ ระดับ 5 86 – 100 คะแนน	เอกสารหรือ หลักฐาน ที่ใช้ประเมิน
การให้บริการ สุขภาพ	เฝ้าระวัง/คัดกรอง V- Scan ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ด้วย 5 สัญญาณเตือนใน ชุมชน เพื่อเพิ่ม การเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วย	ชี้แจงแนวทางการ ดำเนินงาน SMI- V ให้กับหน่วยงาน ในเขตสุขภาพ	ประชาชน ได้รับ การเฝ้าระวัง/ คัดกรองด้วย V- Scan ใน เขตสุขภาพ > ร้อยละ 10	ประชาชนได้รับการ เฝ้าระวัง/ คัดกรอง V-Scan ในเขตสุขภาพ > ร้อยละ 20	ประชาชนได้รับการ เฝ้าระวัง/ คัดกรอง V-Scan ในเขต สุขภาพ > ร้อยละ 30	ประชาชนได้รับการ เฝ้าระวัง/ คัดกรอง V-Scan ในเขตสุขภาพ > ร้อยละ 40	ติดตามใน ระบบ V-CARE และ ให้องค์กรงาน ในสังกัด รายงานความ ก้าวหน้า

ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชสารเสพติดก่อความรุนแรง (SMI-V) ในเขตสุขภาพ เข้าถึงบริการได้รับการดูแลต่อเนื่องและไม่ก่อความรุนแรงซ้ำ



เกณฑ์การประเมินผล ด้านผลกระทบตามกรอบ Result

การเข้าถึงบริการ

Building Block	หัวข้อการประเมิน (นำมาจากมาตรการหลัก)	เกณฑ์คุณภาพ ระดับ 1 0 – 40 คะแนน	เกณฑ์คุณภาพ ระดับ 2 41 – 55 คะแนน	เกณฑ์คุณภาพ ระดับ 3 56 – 70 คะแนน	เกณฑ์คุณภาพ ระดับ 4 71- 85 คะแนน	เกณฑ์คุณภาพ ระดับ 5 86 – 100 คะแนน	เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประเมิน
การเข้าถึงบริการ	ผู้ป่วยโรคจิตเวชสารเสพติดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) เข้าถึงบริการได้ การลดการกลับเป็นซ้ำและป้องกันเหตุรุนแรงในชุมชน	ออกแบบ Template กลาง เพื่อให้ข้อมูลผู้ป่วยจิตเวชสารเสพติดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง แสดงผล Dashboard ครอบคลุม	ข้อมูลผู้ป่วยจิตเวชสารเสพติดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง แสดงผล Dashboard ครอบคลุม	การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคจิตเวชสารเสพติดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) (ร้อยละ 30)	การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคจิตเวชสารเสพติดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) (6 เดือน ร้อยละ 35)	การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคจิตเวชสารเสพติดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) (12 เดือน > ร้อยละ 40)	- รายละเอียด Template - ข้อมูลผู้ป่วยจิตเวชสารเสพติดสามารถแสดงผลหน้า Dashboard ครอบคลุม คิดตามค่าประมาณการ (ตัวหาร) ของ Template

การคำนวณคะแนนผลการประเมินตัวชี้วัดการตรวจราชการ คิดอัตราส่วน 70 : 30

ระดับคะแนนเชิงปริมาณ
(70%)

ระดับคะแนนเชิงคุณภาพ
ด้านผลลัพธ์ (15%)

(คะแนนที่ได้ ÷ 10 x 0.15) = Score

ระดับคะแนนเชิงคุณภาพ
ด้านผลกระทบ (15%)

(คะแนนที่ได้ ÷ 10 x 0.15) = Score

Score เชิงปริมาณ + Score เชิงคุณภาพ = (คะแนนเต็ม 10)

คู่มือการดำเนินการตามตัวชี้วัด

Ebook : คู่มือแนวทางการคัดกรองและการบันทึกรหัสผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V)



<https://moph.cc/kF5EHZJVI>

Ebook : มาตรฐานการปฏิบัติงานการดูแลผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง



<https://moph.cc/ZrJtH6Hk9>

Ebook : ตามคู่มือระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงเพื่อประสิทธิภาพของการดูแลป้องกันการก่อความรุนแรงซ้ำ



<https://moph.cc/E5q55hNIm>



ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชสารเสพติดก่อความรุนแรง (SMI-V) ในเขตสุขภาพ เข้าถึงบริการต่อเนื่องและไม่ก่อความรุนแรงซ้ำ (>ร้อยละ 40)

$$\frac{A = \text{ผู้ป่วยจิตเวชสารเสพติดก่อความรุนแรง (SMI-V) ในเขตสุขภาพ} \\ \text{เข้าถึงบริการได้รับการดูแลต่อเนื่องและไม่ก่อความรุนแรงซ้ำ}}{B = \text{ประมาณการผู้ป่วยจิตเวชสารเสพติดก่อความรุนแรง (SMI-V) ในเขตสุขภาพ (220,405 คน)} \\ \text{เทียบกับประชากรปีก่อนหน้า (ปี 2567)}} \times 100$$

ตัวตั้ง

1. ได้รับการคัดกรองตามเกณฑ์การประเมิน SMI-V ในห้สบริการส่งเสริมป้องกันเฉพาะ (SPECIALPP) มีรหัสอยู่ในช่วง 1B030 - 1B033
 2. ได้รับรหัสโรคของ ICD-10 โรคจิตเภท (F20.xx-F29.xx) โรคซึมเศร้า (F32.xx, F33.xx, F34.1, F38.xx, F39) โรคอารมณ์สองขั้ว (F30.xx-F31.xx) และโรคจิตจากสารเสพติด (F10.xx - F19.xx ยกเว้น F17.xx)
 3. ได้รับรหัส 1B037
- หมายเหตุ ต้องได้รับรหัสครบทั้ง 3 เชื้อไข

ตัวหาร (ค่าคงที่)

1. **หา Estimate SMI= (ค่าความชุก 4.37/100) x ประชากรกลางปี 2567 (15-60 ปี).**
(*Prevalence : Schizophrenia 0.78 / Bipolar 0.06 / Major depressive 2.28 / Drug dependence 1.25 จากผลระบาศดวิทยาสุขภาพจิต 2566)
$$\frac{4.37 \times 42,312,005}{100} = 1,849,035 \text{ คน}$$
2. **หา Estimate SMI-V = (11.92 / 100) x Estimate SMI.**
(ข้อมูลสะสม SMI เทียบ SMI-V สพจ.ขอนแก่น 1 ตค.64-31 พค. 66 = 11.92%)
$$\frac{1,849,035 \times 11.92}{100} = 220,405 \text{ คน}$$

สูตรการคำนวณ



อัตราการเข้าถึงบริการผู้ป่วยจิตเวชและสารเสพติดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V Accessibility Rate) ในเขตสุขภาพ (>ร้อยละ 40)

ผู้ป่วยโรคจิตเวชและสารเสพติดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) ที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา

จำนวนผู้ป่วยโรคจิตเวชและสารเสพติดกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) ที่คำนวณจากความชุกจากระบาดวิทยา 2566

x 100

แหล่งข้อมูล

- ระบบข้อมูล Health Data Center กระทรวงสาธารณสุข (HDC)

ตัวอย่าง

- ป่วยโรคจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) ที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ข้อมูล Health Data Center กระทรวงสาธารณสุข (HDC) 2568 จำนวน 82,667 คน
- ตัวหาร จำนวนประชากรกลางปี 2567 อายุ 15 - 60 ปี 42,312,005 คน มีจำนวนผู้ป่วยจิตเวชที่รุนแรงประมาณการณ หรือ Estimate SMI จากความชุก = 1,849,035 คน ($42,312,005 \times (4.37/100)$) ในจำนวนนี้มีผู้ป่วยจิตเวช SMI-V ประมาณการณ หรือ Estimate SMI-V = 220,405 คน ($1,849,035 \times (11.92/100)$)
- ดังนั้น อัตราการเข้าถึงบริการผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V Accessibility Rate) ในเขตสุขภาพ = 37.5% ($(82,667/220,405) \times 100$)

$$\frac{82,667}{220,405} \times 100$$

37.5 %

คำนิยาม

ผู้ป่วยจิตเวชสารเสพติดชนิดรุนแรง (SERIOUS MENTAL ILLNESS : SMI)

ประกอบด้วยผู้ป่วยวินิจฉัยโรคกลุ่มจิตเภท กลุ่มอารมณ์สองขั้ว กลุ่มอารมณ์ซึมเศร้าชนิดรุนแรง และกลุ่มติดยาและแอลกอฮอล์ ซึ่งผู้ป่วย SMI เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงที่จะก่อความรุนแรงต่อตนเอง ผู้อื่น สิ่งแวดล้อม จากโรคจิตเวชที่เป็นมากกว่าครึ่งหนึ่ง ไม่รับรู้ความเจ็บป่วยของตนเอง จึงไม่ร่วมมือในการรักษา ทำให้แม้จะได้รับการวินิจฉัยแล้ว แต่ไม่ร่วมมือในการรักษาต่อเนื่อง ทำให้อาการกำเริบซ้ำ และก่อความรุนแรงซ้ำได้ ผู้ป่วย SMI ก่อความรุนแรง 11.92% ของผู้ป่วย SMI ทั้งหมด

ผู้ป่วยจิตเวชสารเสพติดก่อความรุนแรง (SMI-V) ในเขตสุขภาพเข้าถึงบริการ

หมายถึง ผู้ป่วยมารับบริการที่สถานพยาบาลและได้รับการวินิจฉัยโรคทางจิตเวชตาม ICD-10 โดยบันทึกตามรหัสโรคของ ICD-10 โรคจิตเภท (F20.xx-F29.xx) โรคซึมเศร้า (F32.xx, F33.xx, F34.1, F38.xx, F39) โรคอารมณ์สองขั้ว (F30.xx-F31.xx) และโรคจิตจากสารเสพติด (F10.xx - F19.xx ยกเว้น F17.xx) และได้รับการคัดกรองตามเกณฑ์การประเมิน SMI-V ในรหัสบริการส่งเสริมป้องกันเฉพาะ (SPECIALPP) มีรหัสอยู่ในช่วง **1B030 - 1B033** เป็นผู้ป่วย SMI-V 1-4

ผู้ป่วยจิตเวชสารเสพติดก่อความรุนแรง (SMI-V) ในเขตสุขภาพเข้าถึงบริการต่อเนื่อง

หมายถึง ผู้ป่วย SMI-V ที่เข้าถึงบริการและจำหน่ายกลับสู่ชุมชนแล้ว ได้รับการดูแลรักษาต่อเนื่องจากสถาบัน/ โรงพยาบาลจิตเวช/ โรงพยาบาลในเขตสุขภาพจากสถานบริการใดก็ได้ (อย่างน้อย 2 ครั้งในปีงบประมาณ) นับจากวันที่มารับบริการครั้งแรกในปีงบประมาณ 2569 โดยมีการประสานงาน ส่งต่อ และติดตามเยี่ยมบ้าน โดยบุคลากรทางสาธารณสุข และ/หรือนัดมาติดตามประเมินอาการที่สถานบริการ (Follow up) และมีการลงรหัสการติดตามผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดก่อความรุนแรง (SMI-V) ในโครงสร้างมาตรฐานข้อมูล 43 แฟ้ม (SPECIAL PP) รหัส **1B037**

ผู้ป่วยจิตเวชสารเสพติดก่อความรุนแรง (SMI-V) ในเขตสุขภาพเข้าถึงบริการต่อเนื่องและไม่ก่อความรุนแรงซ้ำ

หมายถึง ผู้ป่วยจิตเวชสารเสพติดก่อความรุนแรง (SMI-V) ที่ได้รับการดูแลต่อเนื่องอย่างน้อย 2 ครั้งในปีงบประมาณ 2569 และไม่ก่อความรุนแรงซ้ำ



ในโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านสุขภาพ 43 แฟ้ม
(SPECIAL PP) กระทรวงสาธารณสุข

V1

V2

V3

V4

รหัส	คำอธิบาย
1B030	การประเมิน ผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูง พบทำร้ายตนเอง ด้วยวิธีรุนแรง มุ่งหวังให้เสียชีวิต
1B031	การประเมิน ผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูง พบทำร้ายผู้อื่นด้วย วิธีรุนแรง/ก่อเหตุการณ์รุนแรงในชุมชน
1B032	การประเมิน ผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูง พบมีอาการหลงผิด มีความคิดทำร้ายผู้อื่นให้ถึงกับชีวิต หรือมุ่งร้ายผู้อื่นแบบเฉพาะ เจาะจง เช่น ระบุชื่อคนที่จะมุ่งร้าย
1B033	การประเมิน ผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูง พบก่อคดี อาชญากรรมรุนแรง (ฆ่า พยายามฆ่า ข่มขืน วางเพลิง)
1B036	การประเมิน ผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง พบว่าปกติ
1B037	ผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง พบว่าก่อเหตุ ความรุนแรง ทำร้ายตัวเอง/ทำร้ายผู้อื่น/ก่อคดีอาชญากรรมรุนแรง ได้รับการติดตาม
1B038	การประเมิน ผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง พบว่าเป็นประวัติ/อาการอื่น

แนวทางการลงข้อมูล ผู้ป่วยมารับบริการ ณ วันนั้น..... กรณี

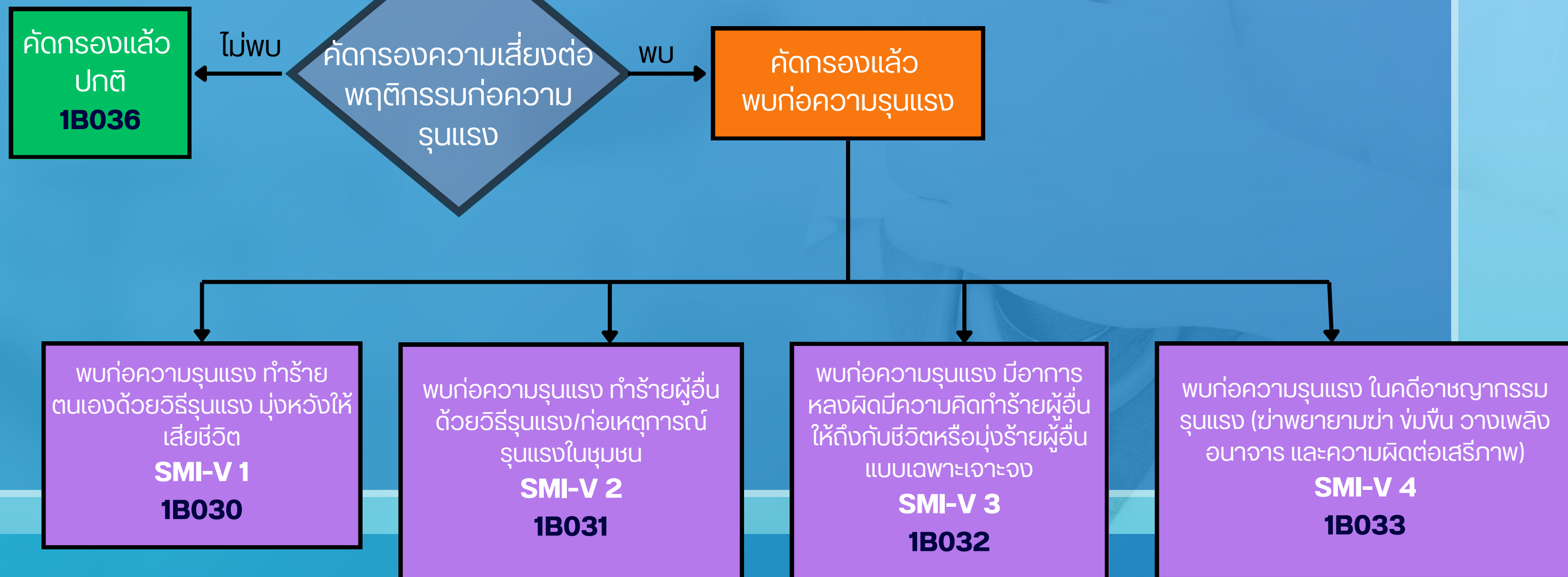
เงื่อนไข	ข้อมูลที่จำเป็น	การลงรหัสวินิจฉัย
SMI-V ก่อความรุนแรง (เข้าถึงบริการ)	- CID/เลขบัตรประชาชน - ชื่อ+สกุล - วัน/เดือน/ปี เกิด - ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน - Dx โรคหลักและร่วม - วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับ Dx - วัน/เดือน/ปี ที่รับบริการ - ข้อมูล 1B030-1B033 และ 1B037	โรคจิตเภท (F20.xx-F29.xx) โรคซึมเศร้า (F32.xx, F33.xx, F34.1, F38.xx, F39) โรคอารมณ์สองขั้ว (F30.xx-F31.xx) โรคจิตจากสารเสพติด (F10.xx - F19.xx ยกเว้น F17.xx) <u>ร่วมกับ 1B030-1B033</u>
SMI-V มาติดตามอาการ (ติดตามต่อเนื่อง)	ข้อมูล 1B030-1B033 และ 1B037	โรคจิตเภท (F20.xx-F29.xx) โรคซึมเศร้า (F32.xx, F33.xx, F34.1, F38.xx, F39) โรคอารมณ์สองขั้ว (F30.xx-F31.xx) โรคจิตจากสารเสพติด (F10.xx - F19.xx ยกเว้น F17.xx) <u>ร่วมกับ 1B030-1B033</u> <u>ร่วมกับ 1B037</u>

คุณภาพข้อมูล/
ความสมบูรณ์
ของแฟ้มข้อมูล

การลงรหัส SPECIAL PP ในการคัดกรองผู้ป่วย SMI-V

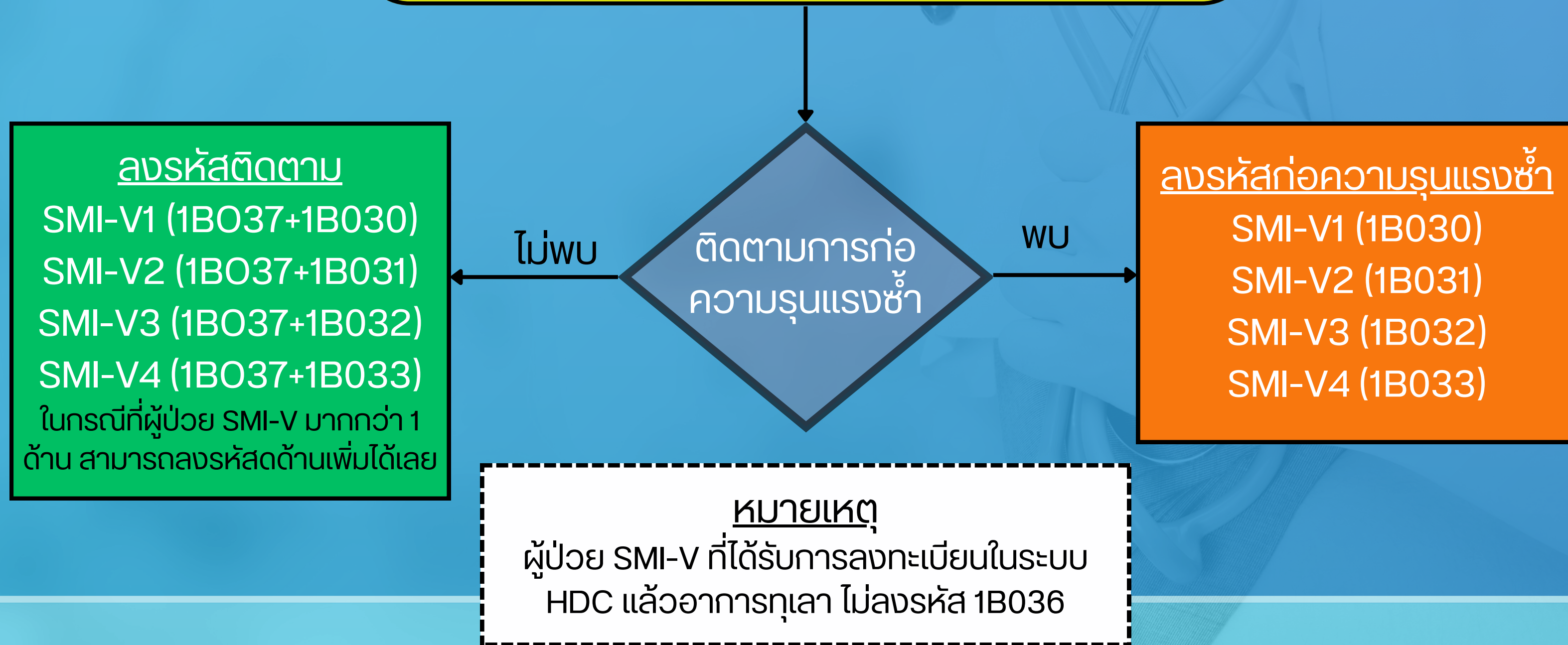
ผู้ป่วยมารับบริการที่สถานพยาบาลและได้รับการวินิจฉัยโรคทางจิตเวชตาม ICD-10 โดยบันทึกตามรหัสโรคของ ICD-10 โรคจิตเภท (F20.xx-F29.xx) โรคซึมเศร้า (F32.xx, F33.xx, F34.1, F38.xx, F39) โรคอารมณ์สองขั้ว (F30.xx-F31.xx) และโรคจิตจากสารเสพติด (F10.xx - F19.xx ยกเว้น F17.xx)

ผู้ป่วยที่คัดกรองจะต้อง ไม่ใช่ ผู้ป่วยที่ได้รับการลงทะเบียน SMI-V ในระบบ HDC



การลงรหัส SPECIAL PP ในการติดตามผู้ป่วย SMI-V

ผู้ป่วย SMI-V ที่ได้รับการลงทะเบียนในระบบ HDC
มารับบริการที่สถานพยาบาล / ติดตามเยี่ยมในชุมชน

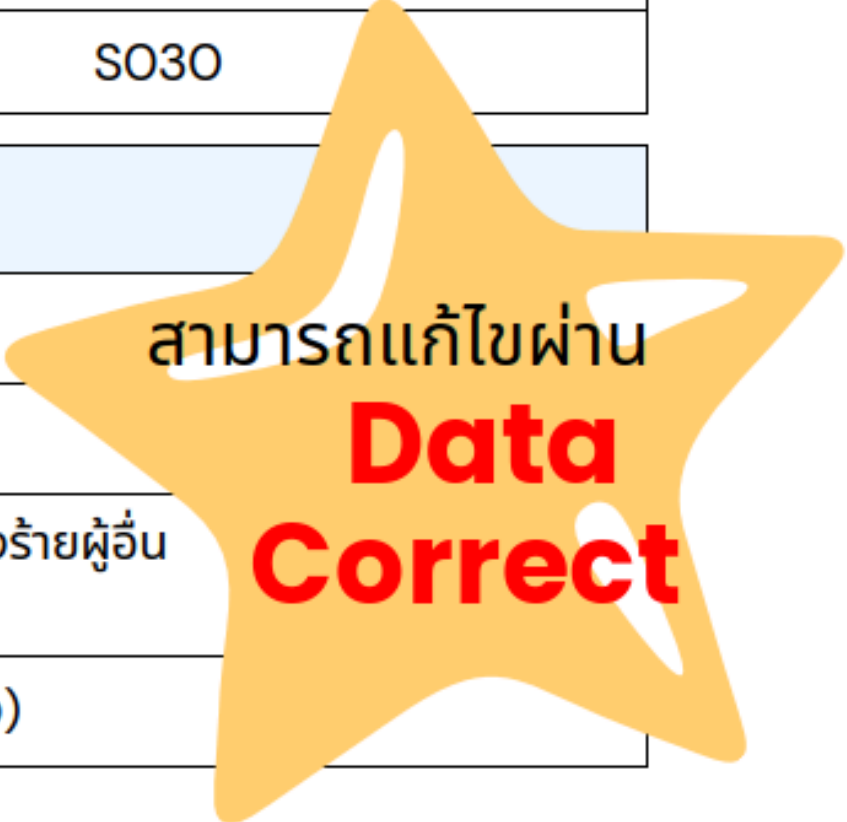


ความคลาดเคลื่อนในการบันทึกรหัส SMI-V สูงสุด 10 ลำดับแรก

วิเคราะห์จากข้อมูลSMI-V (V1-4) ทั้งหมด (31,873 คน)

ICD-10		จำนวน	รหัสคัดกรองในแฟ้ม special-pp
Z010	การตรวจตาและการมองเห็น	4,076	1B1130, 1B1131
Z000	การตรวจร่างกายทั่วไป	3,943	
Z001	การตรวจสุขภาพเด็กตามปกติ	3,620	1B230, 1B231, 1B232, 1B233
Z133	การตรวจคัดกรองพิเศษสำหรับความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรม	2,790	1B130, 1B131, 1B132, 1B133
Z108	การตรวจสุขภาพทั่วไปตามปกติ ของประชากรกลุ่มจำเพาะอื่นที่ระบุรายละเอียด	2,623	1B30, 1B31
Z123	การตรวจคัดกรองพิเศษสำหรับเนื้องอกของเต้านม	2,438	1B0030, 1B0031, 1B0032, 1B0033
Z716	การให้คำปรึกษาผู้ติดบุหรี่	2,032	1B530, 1B531, 1B532
Z718	การให้คำปรึกษาอื่นที่ระบุรายละเอียด	1,855	1B530, 1B531, 1B532
Z136	การตรวจคัดกรองพิเศษสำหรับความผิดปกติของหัวใจ และหลอดเลือด	1,693	1B1230, 1B1231, 1B1232
Z131	การตรวจคัดกรองพิเศษสำหรับโรคเบาหวาน	878	S030

รหัสความรุนแรง SMI-V special-pp	นิยาม
1B030	การประเมิน ผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูง พบทำร้ายตนเองด้วยวิธีรุนแรง มุ่งหวังให้เสียชีวิต
1B031	การประเมิน ผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูง พบทำร้ายผู้อื่นด้วยวิธีรุนแรง/ก่อเหตุการณ์รุนแรงในชุมชน
1B032	การประเมิน ผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูง พบมีอาการหลงผิด มีความคิดทำร้าย ผู้อื่นให้ถึงกับชีวิต หรือมุ่งร้ายผู้อื่นแบบเฉพาะเจาะจง เช่น ระบุชื่อคนที่มุ่งร้าย
1B033	การประเมิน ผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูง พบก่อคดีอาชญากรรมรุนแรง (ฆ่า พยายามฆ่า ข่มขืน วางเพลิง)



ความคลาดเคลื่อนที่อาจจะเกิดขึ้น

DoctorWorkBenchQueueForm - BMS-HOSXP XE 4.0 : 4.64.11.3 DB : hoS4*SiqFf@192.168.0.9:jvkhosxp [MySQL:3306] (โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา ราชชนินทร์: 12268)

Applici OPD R Refer R โยชนา PCU Social Psychia Forensi Physic IPD Re Nurse Doctor Dental ER EMS Dispen Pharm Financ Streche Laborat Patholc Radiolc Operati Checkl Blood E Back O KPI GIS HHC Tools

DoctorWorkBenchQueueForm

รายชื่อผู้ป่วยรอตรวจ Task วันที่ 13/11/2568

ศูนย์คอมพิวเตอร์ : วิชา สุขชนะ

ค้นหา HN

☐ แสดงเฉพาะผู้ที่ได้รับคิวย่อ

ผู้รอคิวตรวจ

ลำดับ คิวรับ ห้องตรวจแรกรับ

<No data to display>

ผู้ป่วยกำลังรับบริการ

ลำดับ	Queue	ผู้ให้บริการ
> 1	133	จตุรงค์ คำทอง
2	90	วิชา สุขชนะพงศ์

รายชื่อผู้ป่วยรอตรวจ

บันทึกข้อมูลซักประวัติ

ใบรับรองแพทย์

EMR

สั่ง Lab

สั่ง X-Ray

Check Up

ขอแปล

Task

บันทึก [F9]

ปิด

Auto refresh

ปิดหน้าจอ

ข้อมูลการให้บริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเฉพาะ

Log

ข้อมูลการให้บริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเฉพาะ

รหัสหน่วยงาน 12268 โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชชนินทร์ []

สถานที่ เจ้าหน้าที่ วิชา สุขชนะพงศ์

วันที่ให้บริการ 13/11/2568 11:20:58

งานที่ให้บริการ ค้นหา

หมายเหตุ pp_special_type_name

180030 : ตรวจคัดกรองความเสี่ยง/โรคมะเร็งเต้านมได้ผลปกติ ผู้รับบริการเคยตรวจด้วยตนเองได้ผลปกติ

180031 : ตรวจคัดกรองความเสี่ยง/โรคมะเร็งเต้านมได้ผลปกติ ผู้รับบริการเคยตรวจด้วยตนเองได้ผลผิดปกติ

180032 : ตรวจคัดกรองความเสี่ยง/โรคมะเร็งเต้านมได้ผลปกติ ผู้รับบริการไม่เคยตรวจด้วยตนเอง

180033 : ตรวจคัดกรองความเสี่ยง/โรคมะเร็งเต้านมได้ผลปกติ ไม่ระบุว่าผู้รับบริการเคยตรวจด้วยตนเองหรือไม่

180034 : ตรวจคัดกรองความเสี่ยง/โรคมะเร็งเต้านมได้ผลผิดปกติ ผู้รับบริการเคยตรวจด้วยตนเองได้ผลปกติ

180035 : ตรวจคัดกรองความเสี่ยง/โรคมะเร็งเต้านมได้ผลผิดปกติ ผู้รับบริการเคยตรวจด้วยตนเองได้ผลผิดปกติ

180036 : ตรวจคัดกรองความเสี่ยง/โรคมะเร็งเต้านมได้ผลผิดปกติ ผู้รับบริการไม่เคยตรวจด้วยตนเอง

180037 : ตรวจคัดกรองความเสี่ยง/โรคมะเร็งเต้านมได้ผลผิดปกติ ไม่ระบุว่าผู้รับบริการเคยตรวจด้วยตนเองหรือไม่

ลบ

ปิด

การนัดหมาย

การส่งตัว

การวินิจฉัย

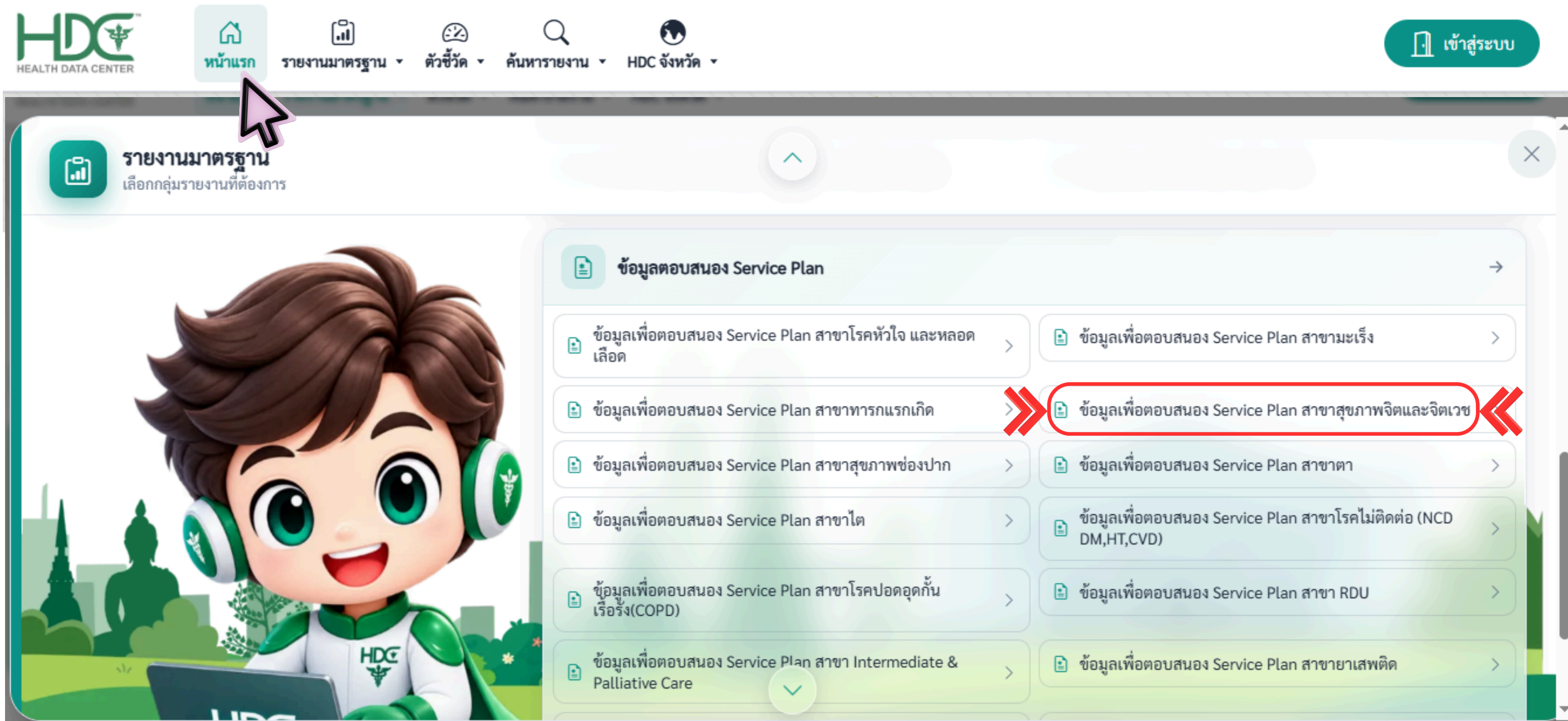
Consult

ลำดับ	Queue	ผู้ให้บริการ
> 1	12268	การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในกลุ่มที่มีอาการซึมเศร้า มโนทัศน์ กลังกลางตอน ในสถานบริการ
2	12268	180260 : การประเมินภาวะซึมเศร้าด้วยแบบประเมิน 9Q พบว่าผลปกติ มโนทัศน์ กลังกลางตอน ในสถานบริการ

CAPS NUM SCRL INS นางวิชา สุขชนะพงศ์ : ศูนย์คอมพิวเตอร์ DESKTOP-3LB9838 192.168.20.109 [1] 0 0 kskdepartment

11:21 13/11/2568

ขั้นตอนการดูรายงานใน >>>>>HDC



The screenshot displays the HDC (Health Data Center) website interface. The top navigation bar includes the HDC logo, a home icon labeled 'หน้าแรก', a bar chart icon labeled 'รายงานมาตรฐาน', a clock icon labeled 'ตัวชี้วัด', a magnifying glass icon labeled 'ค้นหารายงาน', and a globe icon labeled 'HDC จังหวัด'. A 'เข้าสู่ระบบ' (Login) button is located in the top right corner. The main content area features a sidebar with a 'รายงานมาตรฐาน' (Standard Report) section, which includes a sub-section 'เลือกกลุ่มรายงานที่ต้องการ' (Select the report group you want). The main content area shows a list of 'ข้อมูลตอบสนอง Service Plan' (Service Plan Response Data) categories. A red box highlights the category 'ข้อมูลเพื่อตอบสนอง Service Plan สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช' (Service Plan Response Data for Mental and Behavioral Health), which is also pointed to by a red double arrow. The list includes the following categories:

- ข้อมูลเพื่อตอบสนอง Service Plan สาขาโรคหัวใจ และหลอดเลือด
- ข้อมูลเพื่อตอบสนอง Service Plan สาขาทารกแรกเกิด
- ข้อมูลเพื่อตอบสนอง Service Plan สาขาสุขภาพช่องปาก
- ข้อมูลเพื่อตอบสนอง Service Plan สาขาไต
- ข้อมูลเพื่อตอบสนอง Service Plan สาขาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง(COPD)
- ข้อมูลเพื่อตอบสนอง Service Plan สาขา Intermediate & Palliative Care
- ข้อมูลเพื่อตอบสนอง Service Plan สาขามะเร็ง
- ข้อมูลเพื่อตอบสนอง Service Plan สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช
- ข้อมูลเพื่อตอบสนอง Service Plan สาขาทา
- ข้อมูลเพื่อตอบสนอง Service Plan สาขาโรคไม่ติดต่อ (NCD DM,HT,CVD)
- ข้อมูลเพื่อตอบสนอง Service Plan สาขา RDU
- ข้อมูลเพื่อตอบสนอง Service Plan สาขายาเสพติด

- 17** ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดก่อความรุนแรง(SM-V)ได้รับการติดตามดูแลเฝ้าระวังตามแนวทางที่กำหนด(Workload) (อยู่ระหว่างปรับปรุงรายงาน)
- 18** จำนวนผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดก่อความรุนแรง (SMI-V) ที่ขาดการรักษาก่อความรุนแรงซ้ำจำแนกตามประเภทความรุนแรง ที่มารับการรักษาในปีงบประมาณ
- 19** ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชสารเสพติดก่อความรุนแรง (SMI-V) ในเขตสุขภาพเข้าถึงบริการได้รับการดูแลต่อเนื่องและไม่ก่อความรุนแรงซ้ำ
- 20** จำนวนผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดก่อความรุนแรง(SMi-V)ที่มารับบริการในปีงบประมาณ(คนต่อสถานพยาบาล)จำแนกตามการวินิจฉัยปีงบประมาณ(อยู่ระหว่างปรับปรุงรายงาน)

Template HDC

ตัวที่ 19

ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดก่อความรุนแรง (SMI-V)
ในเขตสุขภาพเข้าถึงบริการได้รับการดูแลต่อเนื่องและ
ไม่ก่อความรุนแรงซ้ำ



หน้าแรก



รายงานมาตรฐาน ▾



ตัวชี้วัด ▾



ค้นหารายงาน ▾



HDC จังหวัด ▾



เข้าสู่ระบบ

areheader	จำนวนผู้ป่วย SMI-V (18030-33) รายเก่าทั้งหมด (ตัวเลขอาจมีการเปลี่ยนแปลงตาม จำนวนผู้เสียชีวิตและช่วงอายุ ตาม นิยามผู้ป่วย SMI-V) B	จำนวนผู้ป่วย SMI-V รายใหม่ที่มีมารับบริการ ในปีงบประมาณปัจจุบัน (ยังไม่เคยรับการวินิจฉัย) C	จำนวนผู้ป่วย SMI-V ทั้งหมด (คน) ถึงปัจจุบัน (B+C) D	อัตราการเข้าถึงบริการผู้ป่วยจิตเวช และสารเสพติดที่มีความเสี่ยงสูง ต่อการก่อความรุนแรง ในเขตสุขภาพ (SMI-V Accessibility Rate) สะสม (D/I)*100 E	SMI-V (18030-33) ไม่ก่อความรุนแรงซ้ำ ในปีงบประมาณปัจจุบัน (ผู้ป่วยสะสม) F	ร้อยละผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติด ก่อความรุนแรง (SMI-V) ในเขตสุขภาพเข้าถึงบริการต่อเนื่อง และไม่ก่อความรุนแรงซ้ำ [N/I]*100 (ได้รับการติดตามอย่างน้อย 2 ครั้ง และไม่ก่อซ้ำในปีงบประมาณ) G	ผู้ป่วย SMI-V ได้รับการดูแลต่อเนื่องในปีงบประมาณ และไม่ก่อความรุนแรงซ้ำ				
							ประชากรกลางปี ก่อนปีงบประมาณปัจจุบัน ย้อนหลัง 2 ปี (15-60 ปี) H	ประมาณการผู้ป่วย SMI-V ในพื้นที่สุขภาพ เทียบกับ ประชากรกลางปี (15-60 ปี) ก่อนปีงบประมาณปัจจุบัน ย้อนหลัง 2 ปี I	ติดตาม 1 ครั้ง		
									SMI-V (18030-33) ติดตาม 1 ครั้ง J	SMI-V (18030-33) และไม่ก่อความรุนแรงซ้ำ ภายในปีงบประมาณ) K	ร้อยละผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติด ก่อความรุนแรง (SMI-V) ในเขตสุขภาพเข้าถึงบริการต่อเนื่อง และไม่ก่อความรุนแรงซ้ำ [K/I]*100 L
เขตสุขภาพที่ 1	5,064	1,702	6,766	37.45	5,795	8.84	3,468,659	18,068	2,422	2,181	12.07
เขตสุขภาพที่ 2	1,642	1,061	2,703	23.85	2,206	5.65	2,175,954	11,335	988	909	8.02
เขตสุขภาพที่ 3	2,077	701	2,778	28.87	2,518	7.05	1,847,189	9,622	959	921	9.57
เขตสุขภาพที่ 4	2,618	5,357	7,975	42.72	6,517	12.20	3,583,995	18,669	3,302	3,107	16.64
เขตสุขภาพที่ 5	2,705	2,004	4,709	26.79	3,813	5.73	3,374,247	17,577	1,517	1,436	8.17
เขตสุขภาพที่ 6	5,105	2,261	7,366	33.70	6,498	8.14	4,195,508	21,855	2,555	2,410	11.03
เขตสุขภาพที่ 7	11,752	4,619	16,371	94.53	14,061	18.11	3,324,697	17,318	4,787	4,428	25.57
เขตสุขภาพที่ 8	7,288	10,056	17,344	89.93	13,018	26.62	3,702,629	19,287	7,524	7,255	37.62
เขตสุขภาพที่ 9	5,901	5,466	11,367	49.39	9,715	9.85	4,417,846	23,013	3,349	3,198	13.90
เขตสุขภาพที่ 10	5,352	2,122	7,474	46.74	6,609	7.72	3,069,654	15,990	2,330	2,231	13.95
เขตสุขภาพที่ 11	3,764	2,642	6,406	42.10	5,398	11.97	2,921,319	15,217	2,605	2,439	16.03
เขตสุขภาพที่ 12	2,724	1,884	4,608	27.44	3,877	7.40	3,223,786	16,793	1,907	1,816	10.81
เขตสุขภาพที่ 13	1,002	1,227	2,229	12.16	1,902	2.72	3,519,731	18,334	720	694	3.79
รวม	56,994	41,102	98,096	43.97	81,927	10.45	42,825,214	223,078	34,965	33,025	14.80

Template HDC

ตัวที่ 19

ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดก่อความรุนแรง (SMI-V) ในเขตสุขภาพเข้าถึงบริการได้รับการดูแลต่อเนื่องและไม่ก่อความรุนแรงซ้ำ



หน้าแรก

รายงานมาตรฐาน ▾

ตัวชี้วัด ▾

ค้นหารายงาน ▾

HDC จังหวัด ▾

เข้าสู่ระบบ

ดาวน์โหลดข้อมูล ▾

areaheader	จำนวนผู้ป่วย SMI-V (18030-33) รายเก่าทั้งหมด ก่อนปีงบประมาณปัจจุบัน (ตัวเลขอาจมีการเปลี่ยนแปลงตาม จำนวนผู้เสียชีวิตและช่วงอายุ ตาม นิยามผู้ป่วย SMI-V) B	จำนวนผู้ป่วย SMI-V รายใหม่ที่มาใช้บริการ ในปีงบประมาณปัจจุบัน (ยังไม่เคยรับการวินิจฉัย) C	จำนวนผู้ป่วย SMI-V ทั้งหมด (คน) ถึงปัจจุบัน (B+C) D	อัตราการเข้าถึงบริการผู้ป่วยจิตเวช และสาธารณสุขที่มีความเสี่ยงสูง ต่อการก่อความรุนแรง ในเขตสุขภาพ (SMI-V Accessibility Rate) สะสม (D/I)*100 E	SMI-V (18030-33) ไม่ก่อความรุนแรงซ้ำ ในปีงบประมาณปัจจุบัน (ผู้ป่วยสะสม) F	ร้อยละผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติด ก่อความรุนแรง (SMI-V) ในเขตสุขภาพเข้าถึงบริการต่อเนื่อง และไม่ก่อความรุนแรงซ้ำ [N/I]*100 G (ไม่ได้รับการติดตามอย่างน้อย 2 ครั้ง และไม่มาซ้ำในปีงบประมาณ)	ผู้ป่วย SMI-V ได้รับการดูแลต่อเนื่องในปีงบประมาณ และไม่ก่อความรุนแรงซ้ำ				
							ประชากรกลางปี ก่อนปีงบประมาณปัจจุบัน ย้อนหลัง 2 ปี (15-60 ปี) H	ประมาณการผู้ป่วย SMI-V ในพื้นที่สุขภาพ เทียบกับ ประชากรกลางปี (15-60 ปี) ก่อนปีงบประมาณปัจจุบัน ย้อนหลัง 2 ปี I	ติดตาม 1 ครั้ง		
									SMI-V (18030-33) ติดตาม 1 ครั้ง J	SMI-V (18030-33) ติดตาม 1 ครั้ง และไม่ก่อความรุนแรงซ้ำ ภายในปีงบประมาณ K	ร้อยละผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติด ก่อความรุนแรง (SMI-V) ในเขตสุขภาพเข้าถึงบริการต่อเนื่อง และไม่ก่อความรุนแรงซ้ำ [K/I]*100 L
ปีภาพ	997	939	1,936	130.28	1,464	45.69	285,294	1,486	922	858	57.74
หนองบัวลำภู	1,041	702	1,743	97.59	1,521	35.55	342,916	1,786	919	913	51.12
อุดรธานี	1,217	2,435	3,652	66.39	2,514	14.00	1,056,114	5,501	1,113	1,068	19.41
เลย	394	893	1,287	60.11	874	7.94	411,013	2,141	417	399	18.64
หนองคาย	520	1,243	1,763	98.82	1,345	21.02	342,430	1,784	568	523	29.32
สกลนคร	2,018	1,654	3,672	90.49	2,866	25.53	779,107	4,058	1,582	1,522	37.51
นครพนม	1,101	2,190	3,291	130.08	2,434	58.10	485,755	2,530	2,003	1,972	77.94
รวม	7,288	10,056	17,344	89.93	13,018	26.63	3,702,629	19,286	7,524	7,255	37.62

วันที่ประมวลผล :: 28 สิงหาคม 2569

หมายเหตุ

- ผู้ป่วย SMI-V ทั้งหมดที่เข้าเกณฑ์และยังมีชีวิตอยู่ ณ ปัจจุบัน
- ตัดผู้เสียชีวิตจากฐานข้อมูลกระทรวงมหาดไทย และผู้ป่วย SMI-V อายุเกิน 60 ปี นับตั้งแต่วันที่เกิด จนถึงสิ้นสุดปีงบประมาณ

ขั้นตอนการสมัครใช้งาน >>>>>HDC



**หน้าแรก**

**รายงานมาตรฐาน**

**ตัวชี้วัด**

**ค้นหารายงาน**

**HDC จังหวัด**

**เข้าสู่ระบบ**



ระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ (HDC)
กระทรวงสาธารณสุข
ถ. ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ. เมือง จ.นนทบุรี 11000



สถิตใน
ขอน้อมกรา
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ



ระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ

**ยินดีต้อนรับ**

เข้าสู่ระบบ

เลือกช่องทางเข้าสู่ระบบที่คุณต้องการ

**เข้าสู่ระบบด้วย ThaiID**
แอปพลิเคชันพิสูจน์ตัวตนดิจิทัล

**เข้าสู่ระบบด้วย MyMOPH**
บัญชีกระทรวงสาธารณสุข

**ยังไม่มีบัญชีใช้งาน?** **ลงทะเบียน**

**ThaiID คืออะไร**

**MyMOPH คืออะไร**

ดูรายละเอียด

เข้าสู่ระบบ

ระบบ HDC

**presentation hdc**
โรงพยาบาลชุมชน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

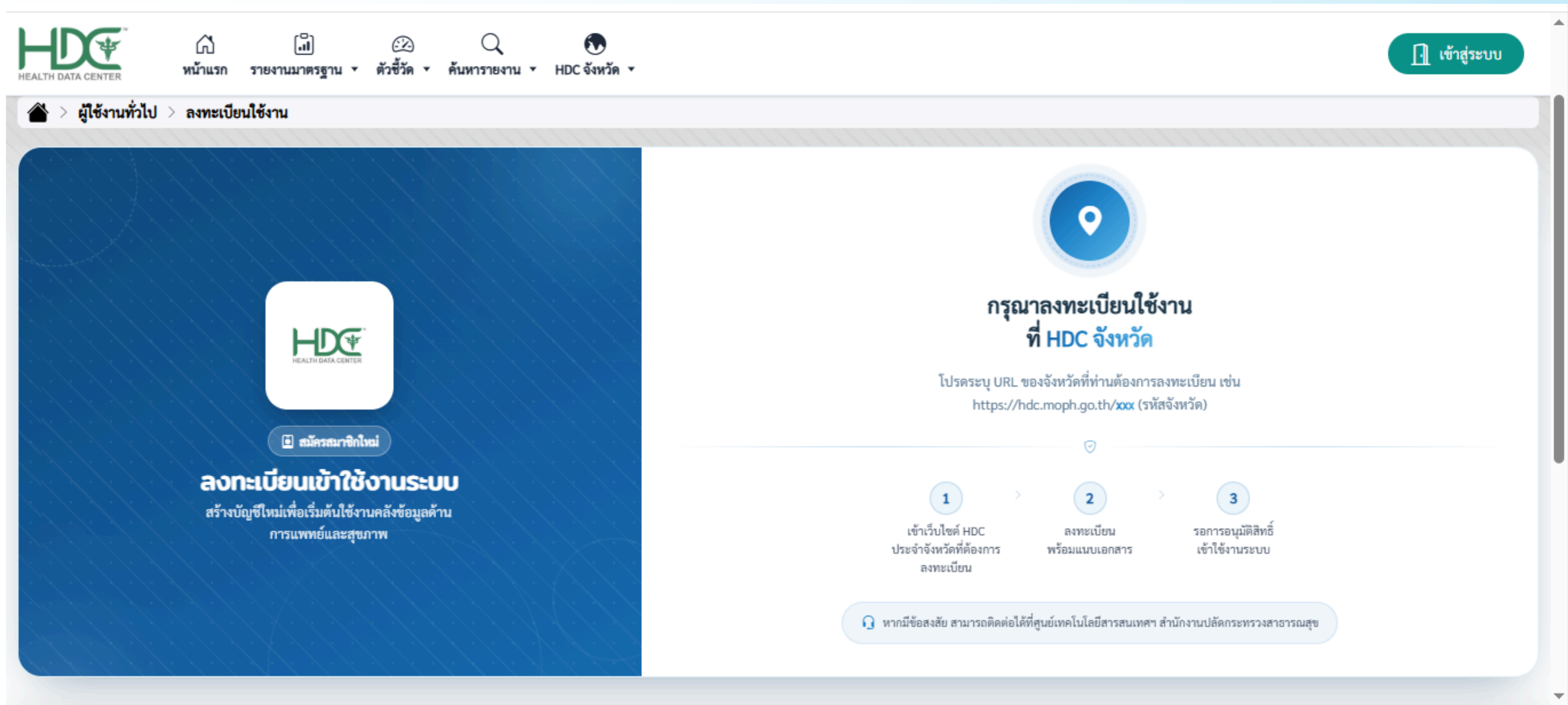
1

เข้าสู่ระบบ

2

เลือกลงทะเบียน

ขั้นตอนการสมัครใช้งาน >>>>>HDC



ขั้นตอนการดู HDC DATA-EXCHANGE ในรายงาน >>>>>HDC

HDC HEALTH DATA CENTER

หน้าแรก รายงานมาตรฐาน ตัวชี้วัด ค้นหารายงาน HDC จังหวัด

เข้าสู่ระบบ

ระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ (HDC)
กระทรวงสาธารณสุข
ถ. ตีพานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ. เมือง จ.นนทบุรี 11000

หน้าแรก

ยินดีต้อนรับ

เข้าสู่ระบบ
เลือกช่องทางเข้าสู่ระบบที่คุณต้องการ

เข้าสู่ระบบด้วย ThaiID
แอปพลิเคชันพิสูจน์ตัวตนดิจิทัล

เข้าสู่ระบบด้วย MyMOPH
บัญชีกระทรวงสาธารณสุข

ยังไม่มีบัญชีใช้งาน? ลงทะเบียน

หน้าแรก

ThaiID คืออะไร

MyMOPH คืออะไร

รายละเอียด

รายละเอียด

คู่มือ เอกสารการใช้งาน

แนะนำระบบ HDC

presentation hdc ICT MOPH

เลือกวิธีการเข้าสู่ระบบ

ขั้นตอนการดู HDC DATA-EXCHANGE ในรายงาน >>>>>HDC



ขั้นตอนการดู HDC DATA-EXCHANGE ในรายงาน >>>>>HDC

1

HDC HEALTH DATA CENTER

หน้าแรก รายงานมาตรฐาน ตัวชี้วัด ค้นหารายงาน HDC จังหวัด

เข้าสู่ระบบ

รายงานมาตรฐาน
เลือกกลุ่มรายงานที่ต้องการ

ข้อมูลตอบสนอง Service Plan

ข้อมูลเพื่อตอบสนอง Service Plan สาขาโรคหัวใจ และหลอดเลือด	ข้อมูลเพื่อตอบสนอง Service Plan สาขามะเร็ง
ข้อมูลเพื่อตอบสนอง Service Plan สาขาทารกแรกเกิด	ข้อมูลเพื่อตอบสนอง Service Plan สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช
ข้อมูลเพื่อตอบสนอง Service Plan สาขาสุขภาพช่องปาก	ข้อมูลเพื่อตอบสนอง Service Plan สาขาทา
ข้อมูลเพื่อตอบสนอง Service Plan สาขาไต	ข้อมูลเพื่อตอบสนอง Service Plan สาขาโรคไม่ติดต่อ (NCD DM,HT,CVD)
ข้อมูลเพื่อตอบสนอง Service Plan สาขาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง(COPD)	ข้อมูลเพื่อตอบสนอง Service Plan สาขา RDU
ข้อมูลเพื่อตอบสนอง Service Plan สาขา Intermediate & Palliative Care	ข้อมูลเพื่อตอบสนอง Service Plan สาขายาเสพติด

2

ขั้นตอนการดู HDC DATA-EXCHANGE ในรายงาน >>>>>HDC

← → ↺ 🌐 hdc.moph.go.th/center/public/standard-subcatalog/22710ed5db1ed6b12aab540a7b0753b3

HDC
HEALTH DATA CENTER

🏠 หน้าแรก 📊 รายงานมาตรฐาน ▾ ⌚ ตัวชี้วัด ▾ 🔍 ค้นหารายงาน ▾

- 17 ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดก่อความรุนแรง(SM-V)ได้รับการติดตามดูแลเฝ้าระวังตามแนวทางที่กำหนด(Workload) (อยู่ระหว่างปรับปรุงรายงาน)
- 18 จำนวนผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดก่อความรุนแรง (SMI-V) ที่ขาดการรักษาก่อความรุนแรงซ้ำจำแนกตามประเภทความรุนแรง ที่มารับการรักษาในปีงบประมาณ
- ③ 19 ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชสารเสพติดก่อความรุนแรง (SMI-V) ในเขตสุขภาพเข้าถึงบริการได้รับการดูแลต่อเนื่องและไม่ก่อความรุนแรงซ้ำ
- 20 จำนวนผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดก่อความรุนแรง(SMi-V)ที่มารับบริการในปีงบประมาณ(คนต่อสถานพยาบาล)จำแนกตามการวินิจฉัยปีงบประมาณ(อยู่ระหว่างปรับปรุงรายงาน)

ขั้นตอนการดู HDC DATA-EXCHANGE ในรายงาน >>>>>HDC

ขั้นตอนการดู HDC DATA-EXCHANGE ในรายงาน >>>>>HDC

LTC R8-WAY

ระบบติดตามดูแลผู้ป่วยจิต...

ระบบการคัดกรองและติ...

Smart Refer

mhsmiv.dmh.go.th

Files - Dropbox

MENTAL HEALTH C...

R8-EOC | ระบบการจัด...

บุ๊กมาร์กทั้งหมด

HDC

HEALTH DATA CENTER

Exchange

หน้าแรก

รายการ Exchange

วอร์สันต์ แผ่นพรหม

01:56:48

ออกจากระบบ

HDC Data-Exchange > ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชสารเสพติดก่อความรุนแรง (SMI-V) ในเขตสุขภาพเข้าถึงบริการได้รับการดูแลต่อเนื่องและไม่ก่อความรุนแรงซ้ำ

กรองข้อมูล

เงื่อนไขการกรอง

ยังไม่ได้เพิ่มตัวกรอง หากต้องการเพิ่มกรุณาคลิกปุ่ม "เพิ่ม" ตัวกรอง

เพิ่ม

ล้าง

ดาวน์โหลด

csv

excel

json

ข้อมูล

รหัสผู้ใช้งาน : 1787972245_H0VT9EIRJ9

คุณมีสิทธิ์ Data Exchange PM ระดับ "จังหวัด" | หน่วยงาน 12277 : โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์

ไฟล์ที่เคยดาวน์โหลดแล้ว

รหัสสถานบริการ/hosrcode	ชื่อหน่วยบริการ/hosname	ทะเบียนบุคคล/pid	เลขประจำตัวประชาชน/cid	ชื่อ/name	นามสกุล/lname	วันเดือนปีเกิด/birth
10711	โรงพยาบาลนครพนม					
11104	โรงพยาบาลปลาปาก					

เงื่อนไข : WHERE c.provcode = '48' LIMIT 100

ประมวลผลเมื่อ 28 สิงหาคม 2026 เวลา 21:06

หน้าแรก

ก่อนหน้า

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ถัดไป

หน้าสุดท้าย

แสดงหน้าละ 100

ทั้งสิ้น 4334 รายการ

1

3

5

7

9

11

13

15

hoscode	hosname	pid	cid	name	lname	birth	sex	chw_addr	tambon	ampur	first_date_serv	date_serv	diagcode	b03x	follow_last	
11451	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช					2004-03-18	1	48	06	05	2025-11-28	2025-11-28 2026-01-24	F322	18031	2026-07-21	
11104	โรงพยาบาล		4		6	1990-02-20	1	44		06	2024-01-24	2024-01-24 2024-11-19	F155 F151 F152	18031	2026-06-08	
10711	โรงพยาบาล					1995-08-2	1	6		01	2025-12-17	2025-12-17		18031	2026-01-23	
11104	โรงพยาบาล					1984-03-0	1	48		02	2025-11-19	2025-11-19 2025-11-19		18031	2026-07-10	
11112	โรงพยาบาล					1992-03-06	1	48	06	10	2023-06-09	2023-06-09 2026-01-24	F1552	18032 18031	2026-07-21	
11110	โรงพยาบาลศรีสงคราม					1995-12-07	1	48	03	08	2025-11-17	2025-11-17	F1552	18031	NULL	
11112	โรงพยาบาลโพธิ์สวรรค์					1997-08-17	1	47	04	02	2025-11-19	2025-11-19 2026-01-24	F155 F151 F152	18031	2026-06-08	
11111	โรงพยาบาลนาหว้า					1988-01-17	1	24	14	05	2025-12-04	2025-12-04 2026-01-24	F29	18031	2026-01-23	
12277	โรงพยาบาลจิตเวชนครพนม					1991-08-24	1	47	01	08	2024-03-04	2024-03-04 2024-03-04	F200 F2090	18031	2026-07-10	
11111	โรงพยาบาลนาหว้า					1995-04-21	1	48	05	09	2023-11-30	2023-11-30 2025-11-19	F1550 F151 F152	18032 18031	2026-06-12	
11110	โรงพยาบาลศรีสงคราม					1996-01-12	2	48	04	08	2024-11-11	2024-11-11 2024-11-11	F3201	18030	2026-06-05	
11451	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช					1996-03-31	1	40	01	01	2025-11-27	2025-11-27 2026-01-24	F129	18031	2026-07-21	
12277	โรงพยาบาลจิตเวชนครพนม					1984-01-25	1	47	01	16	2025-03-21	2025-03-21 2025-11-19	F29 F1551	18031	2025-12-01	
12277	โรงพยาบาลจิตเวชนครพนม					1999-05-15	1	33	20	04	2024-03-04	2024-03-04 2024-03-04	F105 F102 F103	18030	2026-07-09	
12277	โรงพยาบาลจิตเวชนครพนม					2001-02-01	2	47	01	15	2024-03-08	2024-03-08 2025-11-19	F322 F320 F321	18030	2025-12-24	
11111	โรงพยาบาลนาหว้า					2001-12-15	1	47	01	11	2026-01-06	2026-01-06 2026-01-06	F1520	18031	2026-07-21	
11111	โรงพยาบาลนาหว้า					1991-09-15	1	43	01	07	2025-11-30	2025-11-30 2025-11-30	F239 F1550	18031	2026-01-20	
12277	โรงพยาบาลจิตเวชนครพนม					1992-08-29	2	47	99	00	2026-07-25	2026-07-25	F330	18030	2026-07-25	
11112	โรงพยาบาลโพธิ์สวรรค์					1994-07-10	1	48	02	10	2024-07-12	2024-07-12 2024-11-19	F329 F322	18030	2026-05-01	
11451	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช					1994-09-29	1	48	10	05	2025-11-24	2025-11-24 2026-01-24	F155	18031	2026-05-29	
11111	โรงพยาบาลนาหว้า					1998-05-30	1	48	06	09	2025-11-30	2025-11-30 2026-01-24	F1550 F1520	18031	2026-07-21	
12277	โรงพยาบาลจิตเวชนครพนม					1998-09-29	1	47	02	17	2025-12-22	2025-12-22	F200	18030	2025-12-22	
11111	โรงพยาบาลนาหว้า					1999-03-03	1	48	02	09	2025-11-30	2025-11-30 2026-01-24	F239	18031	2026-07-17	
11109	โรงพยาบาลนาแก					1999-01-10	1	48	07	07	2025-11-25	2025-11-25 2026-01-24	F200 F2000	18032	2026-05-05	

- 1.รหัสสถานบริการ/hoscode

2.ชื่อหน่วยบริการ/hosname

3.ทะเบียนบุคคล/pid

4.เลขประจำตัวประชาชน/cid

5.ชื่อ/name

6.นามสกุล/lname

7.วันเดือนปีเกิด/birth

8.เพศ/sex

9.รหัสจังหวัด/chw_addr

10.รหัสตำบล/tambon

11.รหัสอำเภอ/ampur

12. วันเดือนปีที่ได้รับรหัส SMI-V/first_date_serv

13. วันเดือนปีที่ได้รับการวินิจฉัย หรือรับบริการ/ date_serv

14. รหัสวินิจฉัย ICD-10/diagcode

15.รหัส SPECIALPP/b03x

16.วันที่ได้รับการติดตามครั้งสุดท้าย(วันที่ได้รับรหัส 1b037 ครั้งล่าสุด)/follow_last



THANK YOU